علاج:

دورے کے وقت درد، قے اور بے ہوشی کا علاج کیا جائے۔ اس کے لئے مارفیا 1/8 گرین کا انجکشن لگایا جاتا ہے۔ دیگر تدابیر گرم پانی سے ٹکور کرنا یا گرم پانی میں مریض کو بٹھلانا مفید ہے۔ مریض کو پیشاب آور چیزیں مثلاً پوٹاشیم سائٹراس 10 گرین، سپرٹ ایمونیا میلٹک 10 قطرے پانی میں ملا کر دیں۔ دورے کے بعد مریض آرام کرے تاکہ جو ورم وغیرہ پیدا ہو گیا ہو، وہ رفع ہو جائے۔ غذا کا بہت خیال رکھا جائے تاکہ کوئی ثقیل غیر منہضم غذا نہ کھائے۔

اگر مریض کے پیشاب میں کیلشیم اوگزیلیٹ وغیرہ خارج ہو تو اس کے ہاضمہ کو درست کیا جائے۔ ثقیل غذائیں مثلاً چاول، آلو، دال ماش، انڈے اور مٹھائیاں وغیرہ بند کی جائیں۔ شراب بالکل استعمال نہ کی جائے۔ پانی، شربت وغیرہ کے استعمال سے پیاشب کو زیادہ لایا جائے۔ یورک ایسڈ کی پتھری میں کھاری نمکیات مثلاً سوڈا بائی کارب مفید ہیں۔ یا پوٹاشیم سائٹراس دس گرین دو اونس پانی میں ملا کر دیا جائے۔ ورم حوض ۔ردہ کا بیان آگے ذکر کیا جائے گا۔ اگر پتھری بڑی ہو تو اس کا آپریشن بھی کرتے ہیں

دیگر علاج:

تخم کلتھی چھ ماشہ، بادیان چھ ماشہ، کاکنج چھ ماشہ پانی میں شیرہ نکال کر صبح و شام پلائیں۔

دیگر: حجر الیہود ایک تولہ، سنگ سرماہی ایک تولہ، شورہ قلمی ایک تولہ، جوکھار ایک تولہ، مولی کے پانی میں پیس کر رکھیں اور صبح و شام ایک ایک ماشہ ہمراہ پانی دیں۔

دیگر: سیاہ بچھو کی راکھ ایک تولہ، کشتہ حجر الیہود ایک تولہ دونوں کو پیس کر رکھیں۔

مقدار خوراک: ایک رتی صبح و شام دیں۔

پیشاب میں پیپ آنا

اس کی تین اقسام ہیں:

1- پیپ کا مجری البول سے آنا۔

2- گردوں سے پیپ کا آنا۔

Oureshi

3- مثانہ سے پیپ کا آنا۔

علامات:

1- مثانہ سے پیپ کا آنا۔ قارورہ فوری طور پر ٹیسٹ کرنے سے الکلائن' کھاری ہوتا ہے۔ پیپ پیشاب کے اندر پھیلی رہتی ہے۔

2- گردوں سے پیپ کا آنا یا مجری بول سے پیپ کا آنا۔

اس صورت میں پیشاب ایسڈ (تیزابی) ہوتا ہے۔ پیپ نیچے تہہ میں بیٹھ جاتی ہے۔ ان کی علامات علیحدہ علیحدہ درج ہیں۔ اگر پیشاب میں پیپ آتی ہو تو پیشاب کا فوراً ہی ٹیسٹ بذریعہ لٹمس پیپر اگر Reaction یعنی طرز عمل کھاری ہو تو پیپ مثانہ سے آتی ہے۔ اگر تیزابی ہو تو مجری بول یا گردوں سے آتی ہے۔

مجری بول سے پیپ یا تو کسی پھوڑے کے پھوٹنے سے آتی ہے۔ غدی مذی کے پھوڑے سے یا سوزاک کی وجہ سے یا سیون کے پھوڑے سے جو اندر کی طرف پھٹ جائے۔

علاج:

گردے یا مثانہ سے پیپ آنے کا علاج مناسب طریقہ سے کرنا چاہئے۔ اگر یہ امراض اعمال جراحیہ سے تعلق رکھتے ہوں تو ماہر سرجن کا مشورہ طلب کرنا چاہئے۔ اگر ان اعضاء میں کوئی زخم ہو تو دافع تعفن چیزوں کا استعمال ضروری ہے۔ ورم گردہ' ورم مثانہ یا زخم مجری البول سے اگر پیپ آتی ہو تو مناسب تشخیص کے بعد پینسلین کے ٹیکے مفید پائے گئے ہیں۔

نسخہ جات برائے اندمال زخم:

دیگر نسخہ جات جو اندمال زخم میں مفید ہیں' حسب ذیل ہیں:

نسخہ: گل ارمنی تین ماشہ' سنگ جراحت تین ماشہ' طباشیر تین ماشہ' الائچی خورد تین ماشہ' چینی دو تولہ۔

شورہ قلمی ایک ماشہ' پھٹکری ایک ماشہ باریک پیس کر صبح و شام ہمراہ شربت بزوری یا دودھ سے دیا جائے۔

سفوف سلاجیت: سلاجیت' الائچی خورد' پکھان بید' ملٹھی' تالمکھانہ' طباشیر' ست گلو'

Oureshi

کشتہ قلعی ہر ایک تین ماشہ۔ چینی یا مصری ہم وزن۔ خوراک تین ماشہ۔ صبح و شام ہمراہ دودھ استعمال کریں۔

مثانہ و مجاری بول کی پیپ کے زخم کو مفید ہے۔

نیز سوزاک کے لئے بھی فائدہ مند ہے۔

ورم مثانہ (Cystitis)

علامات:

یہ دو قسم کا ہوتا ہے:

1- ورم مثانہ حاد

2- ورم مثانہ مزمن

ورم مثانہ حاد:

اس میں پیپ تھوڑی مقدار میں آتی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا خون بھی ہو سکتا ہے۔ پیشاب تیزابی ہوتا ہے۔ اس میں دھاگے اور چھلکے ہوتے ہیں۔ خانہ کے مقام پر دبانے سے سختی اور درد معلوم ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد درد میں کمی ہو جاتی ہے بشرطیکہ مثانہ میں پتھری نہ ہو کیونکہ اس وقت مثانہ کی دیوار پتھری کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ صحت خراب ہوتی ہے۔ قدرے بخار بھی آتا ہے۔

ورم مثانہ مزمن:

ورم مثانہ حاد کے بعد ہوتا ہے۔

علامات:

پیپ زیادہ مقدار میں آتی ہے۔ پیشاب کر چکنے کے بعد فوراً ٹیسٹ کرنے سے پیشاب کھاری معلوم ہوتا ہے۔ اس میں پیپ زیادہ ہوتی ہے۔ درد اور دوسری علامات کم ہوتی ہیں۔

اسباب:

1- سوزاک

2- سنگ مثانہ

Qureshi

3- اندرونی زخم
4- سلائی وغیرہ ڈالنے سے زخموں کا ہونا
5- سرطان مثانہ
6- رسولی
7- کیتھیٹر کا استعمال جس کو مطہر نہ کیا ہو
8- مثانے کے اندر پیشاب کا فاسد ہو جانا
9- غدہ مذی کا بڑھ جانا
10- اعصابی امراض
11- بندش پیشاب یا فالج یا سرسام
12- ورم جوف عانہ جو پھیل کر مثانہ تک پہنچے
13- مثانے کا مرض سل
14- جراثیم خصوصاً جراثیم قولوں جو کہ سرائیت سے ورم مثانہ پیدا کر دیتے ہیں۔

انجام مرض:

ورم مثانہ احتیاط و علاج سے درست ہو جاتا ہے بشرطیکہ گردوں تک نہ پہنچ جائے لیکن یہ تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے۔ دوبارہ' سہ بارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی رسولی کے عارضے سے ہو تو اس وقت اصولی مرض خراب ہوتا ہے۔

علاج:

سبب کو دور کرنا چاہئے۔ ورم مثانہ حاد میں مکمل آرام کی ضرورت ہے بطور غذا دودھ اور آش جو دینا چاہئے۔ کھاری ادویات خصوصاً پوٹاشیم سائٹراس دس گرین' ٹنکچر ایکو آدھا ڈرام پانی میں ملا کر دن میں دو بار دیں۔ ہلکے ملینات مثلاً میگس سلفاس دو ڈرام' پانی ایک اونس دن میں ایک بار دیئے جائیں۔ شدید درد میں ٹنکچر ہائی سائی مائی دس قطرے پانی میں ملا کر دیں۔

ٹب باتھ (گرم غسل) بھی مفید ہے۔ بعض اوقات بورک ایسڈ کے محلول سے مثانہ کو دھونا بھی مفید ہے۔

دیگر: اگر جراثیم قولون سے ورم مثانہ ہو تو اس صورت میں مندرجہ ذیل نسخہ ایسڈ

Oureshi

فاسفیٹ آف سوڈا بیس گرین' پانی ایک اونس دن میں دو بار دیا جائے۔

ہر خوراک کے دس منٹ بعد ہکسامین (Haxamin) بیس گرین پانی ایک اونس دیا جائے۔ سوزاکی اور جراثیمی ورم مثانہ میں پینسلین کے انجکشن بھی مفید ہیں۔ نیز کسی ماہر سرجن ڈاکٹر سے مشورہ لینا نہایت ضروری ہے۔

قارورے کا وزن مخصوص

صحیح قارورے کا وزن مخصوص عموماً 1010 سے 1016 تک یعنی اگر پانی کا وزن ایک ہزار تولہ ہو تو قارورے کا وزن 1010 سے 1015 تولہ ہو گا۔

قارورے کا وزن مخصوص کم ہونا:

وہ حالات جن میں قارورے کا وزن مخصوص کم ہو جاتا ہے:

1- پرانا ورم گردہ
2- پائی یوریا یعنی کثرت بول اور استسقاء میں

وزن مخصوص کا بڑھنا:

مندرجہ ذیل صورتوں میں وزن مخصوص بڑھ جاتا ہے:

1- ذیابیطس شکری
2- بعض امراض گردہ مثلاً ورم گردہ حاد
3- حمیات یعنی بخار
4- بعض عوارضات مثلاً قے' پسینہ' دست

قاروہ بڑھنے کی وجوہات:

وہ حالات جن میں قارورہ کی مقدار بڑھ جاتی ہے:

1- ذیابیطس شکری
2- ذیابیطس سادہ
3- مزمن ورم گردہ
4- کلیہ شمعی
5- بخاروں کے بعد کی کمزوری

Oureshi

6- اعصابی امراض مثلاً ہسٹریا اور اندرونی رطوبت کے انجذاب سے

قارورہ کم ہونے کی وجوہات:

وہ حالات جن میں قارورہ کی مقدار کم ہو جاتی ہے:

1- ورم گردہ حاد

2- ورم گردہ مزمن انابیسی یعنی نالیوں کا ورم

3- مختلف بخارات

4- قلت پیاس

5- بعض عوارضات مثلاً دست، کثرت پسینہ، سدہ، مجاری کلیہ

ذیابیطس سادہ

علامات:

قارورہ زیادہ مقدار میں آتا ہے لیکن اس میں شکر نہیں آتی۔ قارورہ کی مقدار بعض اوقات پانچ سے دس بوند تک ہوتی ہے۔ قارورہ بالکل صاف ہوتا ہے جیسے کہ پانی۔ اس کا وزن مخصوص 1002 سے 1005 تک ہوتا ہے۔ دیگر علامات عصبی عوارضات مثلاً بے چینی وغیرہ ہوتی ہے۔ جلد کی خشکی، زیادہ بھوک، کبھی دست، کبھی قبض، بے خوابی، درد سر، درد کمر، درد اعضاء غرضیکہ وہی علامات جو ذیابیطس شکری میں بیان کی گئی ہیں۔

اسباب:

1- بدہضمی

2- دماغی محنت

3- رنج و غم و غصہ

4- کمزوری مثانہ و گردہ

5- غذا کی بے اعتدالی وغیرہ

علاج:

محرکات مثلاً چائے، قہوہ کم استعمال کیا جائے۔ نمک کی مقدار میں کمی کی جائے۔ پانی کی مقدار بھی کم کی جائے۔ ادویات میں سنبل الطیب مفید ہے۔

Oureshi

دس گرین سنبل الطیب دن میں دو تین مرتبہ ہمراہ پانی دیا جائے۔ مثانہ کو تقویت دی جائے۔ انڈا اور گوشت کا استعمال کیا جائے۔ میٹھی چیزیں بھی کم کھائی جائیں۔

دیگر مجربات:

جوارش جالینوس صبح و شام ہمراہ کشتہ فولاد دو چاول دیں۔

دیگر: معجون فلاسفہ چھ ماشہ صبح و شام دیں۔

دیگر: کشتہ فولاد ایک تولہ برگ جامن خشک ایک تولہ، تخم جامن ایک تولہ، کشتہ بیضہ مرغ ایک تولہ، کشتہ مرجان دو تولہ، کشتہ صدف مرواریدی ایک تولہ، جفت بلوط تین تولہ، سنبل طیب ایک تولہ، ناگرموتھ ایک تولہ، گوند کیکر دو تولہ۔

سب کو باریک پیس کر گولیاں بنائیں۔ ایک گولی صبح، ایک گولی شام ہمراہ پانی دیں۔ غذا احتیاط سے استعمال کرائیں۔

نوٹ: ذیابیطس سادہ سے ذیابیطس شکری کا بیان گزر چکا ہے۔

بندش بول

یہ ایک بہت خطرناک مرض ہے۔ مثانے میں سلائی داخل کرنے سے پہلے بغور معائنہ کرنا چاہئے۔ اس کی دو قسمیں ہیں:

1- سدی مجاری یعنی حالبین میں رکاوٹ یا سدہ پیدا ہونے کی وجہ سے

2- بغیر سدہ

1- بندش بول سدی:

اس کے اسباب حسب ذیل ہیں:

دونوں حالبین یعنی دونوں گردوں کی پیشاب کی نالیاں جو مثانہ میں کھلتی ہیں، ان میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ گردے صحیح ہوتے ہیں۔ بندش پیشاب کی وجہ پتھری ہوتی ہے یا مثانے کی تہہ میں کوئی رسولی ہوتی ہے جو کہ حالبین میں دباؤ ڈالتی ہے۔

یا حالبین میں کوئی ورم یا رسولی یا تنگی ہوتی ہے۔ اگر ایک ہی طرف حالبین میں خرابی پیدا ہو جائے تو پیشاب میں رکاوٹ نہیں ہوتی بشرطیکہ دوسری نالی اور گردے صحیح کام کر رہے ہوں۔

Oureshi

علامات:

پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ پیشاب ایک ہفتہ تک نہیں آتا۔ مریض کو ابتداء میں کوئی شکایت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ تھوڑی سی غنودگی ہوتی ہے لیکن اگلے روز کے بعد تسمم بول کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ مریض بے چین ہوتا ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں سکڑ جاتی ہیں۔ درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ زبان میلی ہوتی ہے۔ تشنج عضلات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات قے شدت سے آنے لگتی ہے۔ اگر پیشاب دس بارہ دن کے اندر نہ آئے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔

علاج:

سبب کو دور کیا جائے۔ اس صورت میں ماہر سرجن کا مشورہ لینا بھی ضروری ہے۔ ایکسرے سے مدد لینی چاہئے۔

دیگر: نسخہ جات جو پیشاب آور ہیں اور کنکر یا ریت کو خارج کرتے ہیں۔

نسخہ: شورہ قلمی آٹھ گرین، جوکھار پانچ گرین، سمندر جھاگ پانچ گرین باریک پیس کر صبح و شام دیں۔

مریض کو ٹب باتھ کرایا جائے یعنی غسل گرم پانی تاکہ پیشاب کی رکاوٹ اگر ورم سے ہو تو دور ہو جائے۔

2- بندش بول بلا سدہ:

اس کے اسباب درج ذیل ہیں:

1- ورم گردہ حاد
2- غشی جو کہ آپریشن کے بعد یا چوٹ کے بعد یا بخاروں کی وجہ سے پیدا شدہ غشی
3- ہسٹریا
4- زہر سکہ یا فاسفورس
5- شریان گردہ میں سدہ یا رکاوٹ

علامات:

1- پیشاب تیز سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔
2- وزن مخصوص زیادہ ہوتا ہے اس میں البیومن کا اخراج ہوتا ہے۔

Oureshi

3- قے آتی ہے اور دست بھی آتے ہیں' پسینہ آتا ہے۔ دیگر علامات تسمم بول والی ہوتی ہیں۔

علاج:

گرم پانی سے غسل کیا جائے یا گرم پانی سے پسینہ لایا جائے۔ جلد کے فعل کو تیز کیا جائے تاکہ زہر بول پیدا نہ ہو۔ جلاب دیا جائے۔ مثانے کے دونوں طرف یعنی کنج ران پر سنگھیاں لگوائی جائیں۔ ماہر سرجن سے بھی مشورہ کیا جائے۔ دیگر مدارات بول استعمال کی جائیں۔

نوٹ: علاج کا انحصار ازالہ سبب پر ہوتا ہے۔ اس لئے ازالہ سبب کریں۔

چند مجربات مدارات بول:

اگر ورم مثانہ سے بندش بول ہو تو گل ٹیسو گرم پانی میں جوش دے کر زیر ناف دھارا جائے۔

دیگر: پھٹکری خام ایک ماشہ شربت میں گھول کر پلائیں۔

دیگر: سونف تین ماشہ' تخم قرطم تین ماشہ' گل قند دو تولہ پانی میں جوش دے کر علی الصبح پلائیں۔

دیگر: شورہ قلمی ایک ماشہ' جوکھار ایک ماشہ شربت بزوری کے ساتھ پلائیں۔

تسلسل بول

بول کا کئی دفعہ آنا' مقدار کم ہو یا زیادہ۔

یہ دو قسم کا ہوتا ہے:

1- سلسل بول

2- کثرت بول

1- سلسل بول:

اس کے اسباب درج ذیل ہیں:

1- مثانے کی کمزوری۔

2- رحم اور مثانے کے درمیان ناسور کا ہونا۔

Oureshi

3- مثانے کی گردن کا فالج یا ڈھیلا ہونا۔
4- پتھری خارج کرنے کے بعد مثانہ میں کچھ خرابی رہ جانا۔
5- اعصابی کمزوری۔

2- کثرت بول:

اس کی علامات درج ذیل ہیں:

یہ عام مرض ہے۔ مریض پیشاب تو روک سکتا ہے لیکن پیشاب متعدد بار آتا ہے۔ بعض اوقات پیشاب اس تیزی سے آتا ہے کہ اس کا رُوکنا مشکل ہوتا ہے بلکہ اُٹھتے اُٹھتے چند قطرے نکل جاتے ہیں۔

اسباب:

1- گردے مثانے کی کمزوری
2- ذیابیطس سادہ
3- یا وہ اسباب جن کا ہم نے سابق ذکر کیا ہے۔

جوانوں میں کثرت بول کا سبب عموماً ذیابیطس ہی ہوتا ہے۔ بڑی عمر کے لوگوں میں گردے کی خرابی اور غدہ مذی کا بڑھ جانا بھی اس کا سبب ہے۔

یہ غور کرنا چاہئے کہ پیشاب کی مقدار کم ہوتی ہے یا زیادہ۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ اہم سبب کسی خراش کا ہونا ہے مثلاً پیشاب میں تیزابیت کا بڑھ جانا جس سے مثانہ میں خراش ہوتی ہے۔ جراثیم قولون کا مثانے میں پہنچنا۔ غدہ مذی کی وجہ سے خراش کا ہونا۔ یا ورم مثانہ (کوئی زخم اندرون مثانہ)' مثانہ میں رسولی کا ہونا' مثانہ میں پتھری کا ہونا یا منقلب رحم کا مثانہ پر دباؤ پڑنا۔ یا گردے میں کسی پتھری یا غدود کا پیدا ہونا۔ یا مثانہ کے اردگرد کسی عضو سے مثانہ میں خراش پہنچے۔ مثلاً آنتوں کے کیڑے' ضیق غلفہ (یعنی ختنے کا نہ ہونا)' بواسیر' معائے مستقیم کے مسے' رحم میں کسی مسے کا ہونا۔

جوف عانہ میں کسی ورم کا ہونا۔ علاوہ ازیں دیگر اسباب بھی ہیں مثلاً ہسٹریا' ازدواجی زندگی کی کثرت' سوزاک کا ہونا وغیرہ۔

علاج:

ازالہ سبب کیا جائے۔ مندرجہ ذیل نسخہ جات تسلسل البول کے لئے مفید و مجرب

Oureshi

ہیں:

نسخہ: ناگرموتھ ایک تولہ، سنبل الطیب ایک تولہ، سونٹھ ایک تولہ، کالی مرچ ایک تولہ، شہد خالص دو تولہ، کشتہ فولاد اصلی چھ ماشہ۔ سب کو باریک پیس کر حب بقدر نخود بنائیں۔

ایک گولی صبح ایک گولی شام ہمراہ دودھ۔

دیگر: کشتہ فولاد ایک تولہ، کشتہ بیضہ مرغ ایک تولہ، کشتہ مرجان ایک تولہ، کشتہ بارہ سنگا ایک تولہ۔ ان سب کو خوب پیس کر رکھیں۔ دو چاول صبح و شام ہمراہ مکھن یا بالائی استعمال کریں۔

دیگر: اگر کمزوری اعصاب سے مرض ہو تو ثعلب مصری، دروخ عقربی، مغز چلغوزہ، تل سفید، مغز بادام، زنجبیل ہر ایک ایک تولہ باریک پیس کر شہد مصفی میں قوام کر کے رکھیں۔ چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ دودھ استعمال کریں۔

دیگر: معجون جالینوس تین ماشہ، کشتہ فولاد دو چاول صبح و شام کھلائیں۔

دیگر: جوارش فلاسفہ چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ کشتہ فولاد دو چاول کھلائیں۔

دیگر: لبوب کبیر چھ ماشہ صبح و شام استعمال کریں۔ مریض کو انڈا اور گوشت کھلائیں۔ چاولوں سے پرہیز ضروری ہے بشرطیکہ حرارت کا غلبہ ہو۔

دیگر: اگر تیزیٔ پیشاب اور قارورہ میں ترشی زیادہ ہو تو کھاری ادویات مثل شربت بزوری ہمراہ کھار بھنکرہ دیں۔

دیگر: برائے ترشی پیشاب نمک پانیوس، نمک گانگ ایک ایک ماشہ صبح و شام دیں۔ قبض کشا کریں۔ گرم شکم ہو تو ان کو خارج کریں۔

بول بستری

اسباب:

1- بچوں میں دماغی اعصابی کمزوری۔
2- مثانہ میں پتھری کا ہونا۔
3- حلق میں غدود کا بڑھ جانا۔

علاج:

اگر مثانہ میں کوئی خراش وغیرہ ہو۔ اس کو دور کیا جائے۔ پیشاب کی تیزابیت کم

Oureshi

کرنے کے لئے کھاری ادویات مثلاً سوڈا بائی کارب دس گرین۔ ٹنکچر ہائی سائی مائی پانچ قطرے، پانی ایک اونس میں ملا کر دیتے ہیں۔ یا پوٹاشیم سائٹراس دس گرین، ٹنکچر ہائی سائی مائی پانچ قطرے پانی میں ملا کر دی جائے۔

اگر مثانے کی کمزوری ہو تو ٹنکچر بیلاڈونا پانچ قطرے، ٹنکچر نکس وامیکا پانچ قطرے، پانی ایک اونس ملا کر پینا نہایت مفید اور مجرب ہے۔ اگر اعصاب میں تیزی ہو تو پوٹاشیم برومائیڈ پانچ گرین دینا مفید ہے۔

بول بستری میں بچوں کو رات کو پیشاب کر کے سلایا جائے۔ پشت کے بل نہ سلایا جائے۔ کمر پر اور پشت پر ٹھنڈے پانی سے بطول کرنا بھی مفید ہے۔

بول بستری میں والدین بچوں کو سزا دینے میں پرہیز رکھیں۔

رسوبات بول

قارورہ میں مختلف رسوبات خارج ہوتے ہیں مثلاً:

1- یوریٹ	2- یورک ایسڈ	3- فاسفیٹ
4- اوگزیلیٹ	5- چربی	6- پیپ
7- خون	8- جراثیم	9- کیلوس و دیگر وغیرہ

اسباب:

ان رسوبات کے نکلنے کے اسباب پر سابق روشنی ڈال دی ہے۔

مندرجہ ذیل کے متعلق مزید روشنی ڈالی جاتی ہے:

1- فاسفیٹ:

قارورہ گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ قارورہ میں ابر کی مانند مادہ تہہ نشین ہوتا ہے۔ پیشاب بھی کئی دفعہ آتا ہے۔ قارورہ کھاری ہوتا ہے۔ لسی کی مانند سفید قارورہ پیشاب کرنے کے وقت پہلے یا بعد میں خارج ہوتا ہے۔

اسباب:

1- ہضم کی خرابی

2- جگری کی کمزوری

Oureshi

اس کے اسباب ہیں۔ اس کے علاوہ اعصابی کمزوری اور دماغی محنت بھی اس کے اسباب ہیں۔ زیادہ مقدار میں فاسفیٹ اس وقت خارج ہوتا ہے جبکہ دیر ہضم سبزیاں مثل آلو، گوبھی کھالی جائیں۔

علاج:

مذکورہ اسباب کو دور کیا جائے۔ جگر کی اصلاح کی جائے۔ مندرجہ ذیل مرکبات کا دینا مفید ہے۔

ٹنکچر نکس وامیکا پانچ قطرے، ایسڈ ہائیڈرو ہورک ڈل دس قطرے پانی ایک اونس دن میں دو تین مرتبہ دیئے جائیں۔ پریشانی اور دماغی محنت کو کم کیا جائے۔ غذا ہلکی ہو، ورزش کی جائے اور کبھی کبھی آدھا دن کچھ نہ کھانا پینا فائدہ دیتا ہے۔

دیگر مجربات:

معجون مقوی جگر، دافع اخراج، فاسفیٹ کیلشیم، چونا، اجزائے کیلونیہ جو پیشاب میں خارج ہوتے ہیں۔

نسخہ: سنبل الطیب چھ ماشہ، ناگرموتھ چھ ماشہ، کوٹھ فلفل چھ ماشہ، فلفل دراز چھ ماشہ، عود بلسان چھ ماشہ، سونٹھ چھ ماشہ، حب آلاس چھ ماشہ، الائچی سبز چھ ماشہ، لونگ چھ ماشہ، چرائتہ شیریں سب کو باریک پیس کر شہد ڈیڑھ پاؤ کا قوام کر کے معجون بنائیں۔

خوراک: تین ماشہ صبح و شام ہمراہ پانی۔

دیگر: جوارش زرعونی چھ ماشہ صبح و شام ہمراہ پانی دیں۔

دیگر: کشتہ فولاد دو چاول ہمراہ جوارش زرعونی صبح و شام دیں۔

دیگر مجربات مسیح الملک حکیم اجمل خان:

1- بادیان تین ماشہ، کشمش (سوگی) تین ماشہ، الائچی خورد تین ماشہ، گل قند دو تولہ۔ پانی میں پیس کر صبح و شام دیں۔

2- گل قند دو تولہ، مصطگی رومی ایک ماشہ، سونف ایک ماشہ۔ صبح و شام خوب چبا کر کھائیں۔

2- اوگزی لیٹ:

یہ بھی ایک قسم کا رسوب ہے جس میں چونا وغیرہ کے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو تہہ

Oureshi

نشین ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پسا ہوا پھر ہے۔ یہ چونا کی ایک قسم ہے۔

اسباب:

1- ہضم کی خرابی
2- غدہ بانقراس کی خرابی
3- نظام عصبی کی کمزوری
4- تحلیل اعضاء (اعضاء کا گھل کر آنا)

علاج:

پیشاب چیک کیا جائے۔ ہضم کی درست کی جائے۔ غذا میں دودھ، خربوزہ، ناشپاتی، شلغم، پالک، روٹی دی جائے۔ شکر سے پرہیز کیا جائے۔ ہلکی غذائیں استعمال کی جائیں۔

3- چربی کا اخراج:

یہ عموماً ورم گردہ مزمن میں آتی ہے۔ اس کے ساتھ کیلوسن کا بھی اخراج ہوتا ہے جس کا مفصل بیان آگے گزر چکا ہے۔

علاج:

جگر کی درستی کی جائے۔ ہاضمے کی اصلاح کی جائے۔ مریض کو مقوی غذا دی جائے۔ دماغی پریشانی دور کی جائے۔ غذا زود ہضم ہو۔ مثل شوربا اور فروٹ۔

امراض مثانہ و غدہ قدامیہ

چونکہ پیشاب کا تعلق مثانہ سے بھی ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم یہاں کچھ امراض مثانہ کا ذکر کریں۔

مثانہ ایک عضو لطیف مثل جھلی کے ہے۔ اس کے اندرونی حصہ میں غشاء مخاطی کا استر، اوپر کے حصہ میں ایک جھلی جس کے اوپر غشاء باریطون کا سر مثانہ جوف عانہ میں واقع ہے۔ اس کا طول تقریباً پانچ انچ اور عرض چار انچ واقع ہے۔ موٹائی ایک انچ۔

مردوں میں مثانہ کے نیچے معائے مستقیم یعنی پاخانہ کی آنت ہے۔ عورتوں میں مثانہ کے نیچے رحم اور اس کے نیچے معائے مستقیم واقع ہے۔

Oureshi

تشخیص امراض و علاج مثانہ میں تشریح کا جاننا ضروری ہے کیونکہ ایک عضو کا دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک کے مرض کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے۔

ورم مثانہ حاد (Acute Cystitis)

علامات:

سیون اور عانہ کے مقام پر درد ہوتا ہے۔ دبانے سے سختی معلوم ہوتی ہے۔ مثانہ میں بے چینی ہوتی ہے۔ پیشاب بمشکل تمام خارج ہوتا ہے۔ اگر خارج ہوتا ہے تو تھوڑا ہوتا ہے۔

اس میں عموماً پیپ اور خون کی آمیزش ہوتی ہے۔ رکھنے سے فوراً کھاری ہو جاتا ہے۔ اس میں جراثیم بھی پائے جاتے ہیں۔ مریض تکلیف اور بے چینی سے جان کھو دیتا ہے اور اگر ورم عنق مثانہ میں ہو تو پیشاب رُک جاتا ہے۔ مثانہ پھول جاتا ہے۔

علاج:

مریض کو گرم کپڑے پہنائے رکھیں۔ مثانہ کے مقام پر ٹکور کریں۔ یا السی کی پلٹس باندھیں۔ غسل آبی دینا بھی مفید ہے۔ اصولاً ورم حاد مثانہ میں کوئی اوزار نہیں ڈالنا چاہئے تاکہ سوزش زیادہ نہ ہو۔

اس مرض میں واقع تعفن ادراری ادویات مفید پائی گئی ہیں۔ مثل یوروٹروپین پانچ سے پندرہ گرین پانی کے ساتھ۔ اس کے ہمراہ کبھی ایسڈ فاسفیٹ آف سوڈا بھی پانچ گرین ملا دیتے ہیں۔

دیسی علاج تحلیل ورم کے لئے گل خطمی دو تولہ پانی میں جوش دے کر ٹھنڈا کر کے چھان کر شربت بزوری ملا کر دیں۔ یا بہیدانہ تین ماشہ، اسبغول چھ ماشہ پانی میں بھگو کر لعاب نکال کر چینی ملا کر صبح و شام دیں۔

مثانہ کے مقام پر گل خطمی، گل بابونہ، گل سرخ ہر ایک دو تولہ پانی میں گھوٹ کر نیم گرم پلٹس باندھیں۔

ٹکور کی جائے۔ السی کی پلٹس بھی مفید ہے۔

دیگر: قبض کشائی کریں۔ اس غرض کے لئے کسٹر آئل چار تولہ دینا مفید ہے۔

Oureshi

ورم مثانہ مزمن

اس کے اسباب مختلف ہیں۔

ورم مثاہن حاد کا ورم مثانہ مزمن میں تبدیل ہونا' مثانہ میں پتھری' رسول' قرحہ سلی کی موجودگی' پرانے سوزاک کا مثانہ تک پھیل جانا' اس کے علاوہ پیشاب کا زیادہ دیر رُکنا بھی ایک سبب ہے۔ غدہ مذی کا بڑھ جانا یا سوزاک کی وجہ سے مجری بول کی تنگی بھی ایک اہم سبب ہے۔

علامات:

مریض بے چینی محسوس کرتا ہے اور رات کو پیشاب کے لئے متعدد دفعہ اُٹھتا ہے۔ پیشاب گدلا ہوتا ہے۔ پیشاب کو رکھا جائے تو اس میں رطوبت مخاطی اور پیپ تہ نشین ہو جاتی ہے۔ اس میں چھلکے ہوتے ہیں۔ نیز پیشاب میں کثیر مقدار فاسفیٹ اور چونے کے اجزاء کی ہوتی ہے۔ جو تہہ نشین ہو جاتے ہیں۔

قارورہ الکلائن (کھاری) ہوتا ہے۔ اس سے نہایت خراب بدبو آتی ہے جیسے کہ تیز نوشادر کی۔

اگر مرض بڑھ جائے تو مجری بول اور گردے بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور ورم گردہ ہو جاتا ہے۔

تشخیص جلد ہونی چاہئے۔ مثانہ کا معائنہ بذریعہ سٹے سٹوسکوپ ہونا چاہئے۔

علاج:

سرجن سے مشورہ ضرور لینا چاہئے۔ اگر مرض جراحیات سے تعلق رکھے تو مریض کو ہسپتال میں داخل کیا جائے۔

دیگر تدابیر و علاج:

مریض کو آرام اور سکون سے رکھیں۔

مثانے کا ایکسرے لیا جائے تاکہ پتھری' ورم اور رسولی کی تشخیص ہو۔

غذا:

مریض کی غذا ہلکی پھلکی اور نرم ہو۔ محرک' تیز نہ ہو۔ شراب ترک کی جائے۔

Oureshi

دودھ دیا جائے۔ آش جو بھی مفید ہے۔ ہلکی مدارات مفید ہیں۔

شیرہ تخم خیارین تین ماشہ، تخم خربوزہ تین ماشہ، تخم کاسنی تین ماشہ پانی میں نکال کر دن میں دو تین مرتبہ دیں۔

اگر پیشاب میں درد جلن ہو اور رطوبت مخاطی اور پیپ کا اخراج زیادہ ہو تو روغن صندل پانچ سے دس قطرے پانی یا بتاشے میں رکھ کر دیں۔

سلعہ مثانہ یا مثانہ کی رسولی

علامات:

مثانہ سے پیشاب کے ساتھ بار بار خون کا اخراج۔ اسکے ساتھ مثانہ میں خراش۔

سرطان مثانہ

علامات:

سلعہ مثانہ کے ساتھ ملتی ہیں۔

علاج:

ماہر سرجن سے مشورہ کیا جائے۔

سنگ مثانہ

علامات:

پیشاب کے ساتھ خون کا آنا۔ پیشاب کا تھوڑا تھوڑا آنا۔

علاج:

ایکسرے کیا جائے۔ نیز ماہر سرجن کا مشورہ لیا جائے۔

مثانہ کی سستی

اس سے مراد مثانہ کی قوت دافع کی کمزوری ہے۔ مریض پیشاب کرتا ہے لیکن پورے طور پر پیشاب کو خارج نہیں کر سکتا۔

Oureshi

اسباب:

عضلات مثانہ کی کمزوری' پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنا یا آپریشن کے دوران کسی خاص خامی کا رہ جانا۔ بڑھاپے میں غدہ مذی کا بڑھ جانا یا تنگی مجریٰ بول۔

علامات:

پیشاب بمشکل خارج ہوتا ہے۔ یا قطرہ قطرہ آتا ہے۔ کھل کر دھار نہیں آتی۔ نتیجتاً قارورہ کا رسوب تہہ نشین ہوتا ہے اور مزمن ورم مثانہ بن جاتا ہے۔

علاج:

مقویات دیں۔ معجون اذاراقی بہت مفید ہے۔

خوراک: آدھا ماشہ صبح و شام ہمراہ پانی۔

دیگر: معجون فلاسفہ دیں۔ تین ماشہ صبح و شام ہمراہ پانی۔

دیگر: ''شدھ مگر دھوج'' کھلائیں۔ ایک گولی صبح و شام ہمراہ پانی۔

دیگر: کچلہ تولہ' کالی مرچ پانچ تولہ پیس کر حب بقدر خشخاش بنا کر ایک گولی صبح و شام ہمراہ پانی۔

عوارضات غدہ قدامیہ

ورم غدہ قدامیہ حاد' ورم غدہ مذی' سوزاک کے اثر سے پیدا ہوتا ہے۔ یا مثانہ میں پیشاب روکے رکھنے سے۔ یا سردی لگ جانے سے یا ٹھنڈی جگہ مثل ٹھنڈے پتھر پر یا ٹھنڈی گھاس پر زیادہ بیٹھنے سے یا مزمن قبض سے یا بڑھاپے میں کمزوری اعصاب کے اثرات سے۔

علامات:

عنق مثانہ کے مقام پر درد ہوتا ہے۔ نیز بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ پیشاب بار بار اور درد سے آتا ہے۔ نیز رفع حاجت یعنی پاخانہ کے وقت تکلیف اور بے چینی ہوتی ہے۔ جوں جوں ورم بڑھتا ہے' درد زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اُٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مقعد کا معائنہ کر کے غدہ مذی بڑھا ہوا' گرم اور سخت معلوم ہوتا ہے۔

بعض اوقات اس سے پھوڑا بھی بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پیشاب بھی رُک

Oureshi

جاتا ہے۔
پھوڑا پھٹ کر اردگرد اعضاء میں بھی پھیل جاتا ہے۔

علاج:

مریض کو آرام سے رکھیں۔ قبض کشائی کریں۔ اگر ورم سیون کے مقام پر زیادہ ہو تو دس بارہ جونکیں لگوائیں۔ ہپ باتھ' غسل آبی بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ السی کی پلٹس باندھنا بھی مفید ہے۔
اگر پیشاب رُک جائے تو ماہر معالج سے بذریعہ کیتھیٹر سلائی پیشاب نکال دیا جائے۔ اگر پھوڑا بن جائے تو سرجن سے مشورہ لینا ضروری ہے۔

عظم غدہ قدامیہ (غدہ مذی کا بڑھ جانا)

یہ ایک حالت مرض ہے جو کہ بڑھاپے میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ عموماً پیشاب کی خرابی یا بے قاعدگی کا نتیجہ ہے اور اس کے پیدا ہونے سے زندگی کے ایام تکلیف سے گزرتے ہیں کیونکہ اس کے (غدۂ قدامیہ کے بڑھ جانے سے) گردہ اور مثانہ پر پچھلی طرف دباؤ پڑتا رہتا ہے جن سے ان اعضاء میں تغیر اور خرابی پیدا ہوتی رہتی ہے۔
غدہ مذی بڑھ کر ناشپاتی جتنا موٹا بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس سے کم اور زیادہ بھی۔ اس کے بڑھنے سے ورم مثانہ مزمن' ورم گردہ' ورم گردہ مائی پیدا ہو جاتے ہیں جن سے زہر بول اکٹھا ہوتا جاتا ہے۔

اسباب:

ضعف اعصاب' مثانہ کی کمزوری' ہضم کی خرابی' شکم پُری' پیشاب کو روکے رکھنا' دائمی قبض وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔ علاوہ ازیں زیادہ بیٹھے رہنا' چلنے پھرنے سے احتراز کرنا بھی اس مرض کا موجب ہیں۔

دیگر علامات ورم غدہ مذی یا پراسٹیٹ گلینڈز:

مریض پیشاب کرنے میں تنگی اور تکلیف محسوس کرتا ہے' زور لگاتا ہے۔ رسوب کے جمع ہونے سے آہستہ آہستہ مثانہ کی خراش بڑھتی جاتی ہے۔ مریض متعدد دفعہ پیشاب کرتا ہے خصوصاً رات کے وقت سیون کے مقام پر بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات

Oureshi